

GALS

Gait – Arms – Legs – Spine

Un examen clinique de dépistage des troubles
de l'appareil locomoteur

FACILE ET RAPIDE

Dr S. Genevay avril 2020 d'après

M Doherty Annals of the Rheumatic Diseases 1992; 51: 1165-69

Anamnèse : 3 questions

- Avez-vous des douleurs ou des raideurs dans les muscles, les articulations ou la colonne vertébrale?
- Pouvez-vous vous habiller complètement sans difficulté ?
- Pouvez-vous monter et descendre les escaliers sans difficulté ?

Examen clinique

Marche

Patient en sous-vêtements !

Demander à faire quelques pas et revenir: observez !

- Symétrie, fluidité du mouvement
 - ballant des bras, bascule du bassin, jambes
- Longueur du pas
- Vérifier une marche normale
 - contact du talon au sol
 - phase d'appui
 - décollement du pied
 - phase oscillante
- Demi-tour exécuté rapidement

Examen clinique

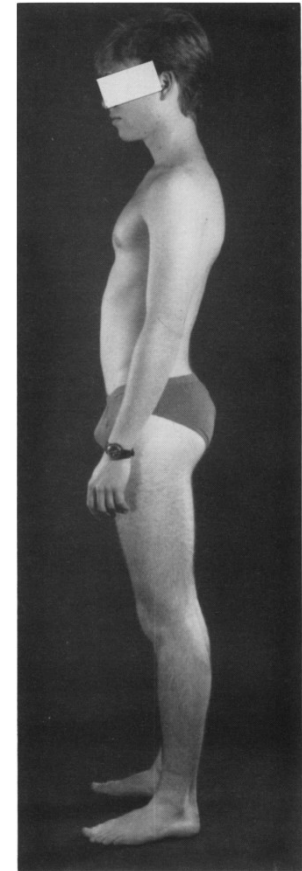
De dos

- Alignement des épineuses (absence de scoliose)
- Symétrie de la musculature ceinture scapulaire
 - Trapèzes, deltoïdes, sus & sous épineux)
- Symétrie de la musculature paraspinale
- Symétrie de la musculature ceinture pelvienne
 - Fessiers
- Crêtes iliaques horizontales
- Pas de tuméfaction poplitée (= kyste poplité)
- Pas de tuméfaction de l'arrière pied (tendon d'Achille)

Examen clinique

De profil

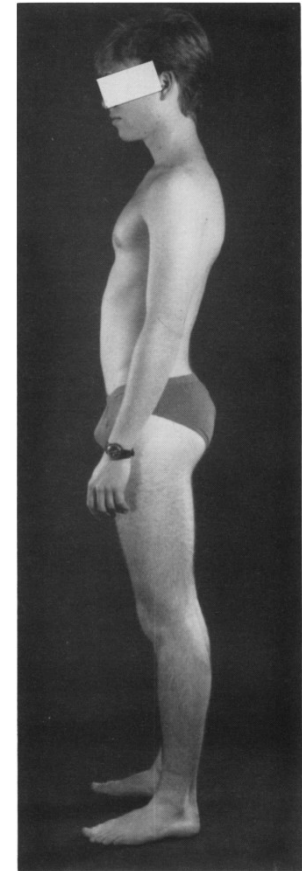
- Courbures harmonieuses et équilibrée
 - Lordose cervicale
 - cyphose thoracique
 - lordose lombaire
- « Penchez-vous en avant et allez toucher vos orteils en gardant les jambes tendues »
 - Flexion dorsale + lombaire + hanches



Examen clinique

De profil

- Courbures harmonieuses et équilibrée
 - Lordose cervicale
 - cyphose thoracique
 - lordose lombaire
- « Penchez-vous en avant et allez toucher vos orteils en gardant les jambes tendues »
 - Flexion dorsale + lombaire + hanches



Examen clinique

De face : cervical

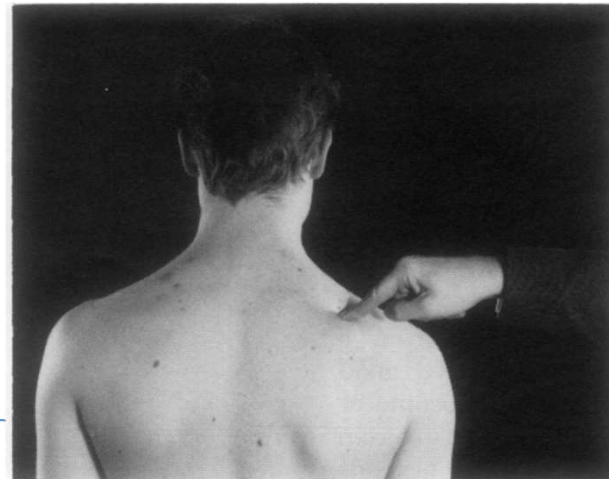
Colonne vertébrale cervicale

- « Essayez de toucher votre épaule droite puis gauche avec votre oreille »
 - Inclinaison normale de la tête des 2 côtés



Dépistage syndrome douloureux chronique diffus

- Palper le sus-épineux



Examen clinique

De face : mouvement MS

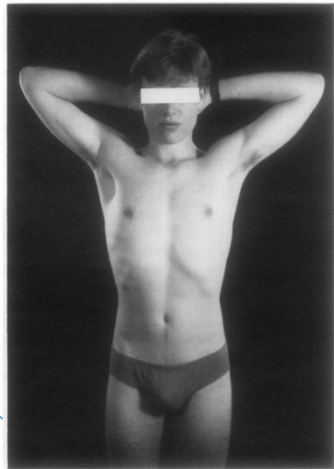
- « Mettez les bras derrière la tête, les coudes en arrière »

Glenohumérale

Sterno-claviculaire

Acromio-calviculaire

Flexion coude



- « Baissez les bras le long du corps »

Extension coude

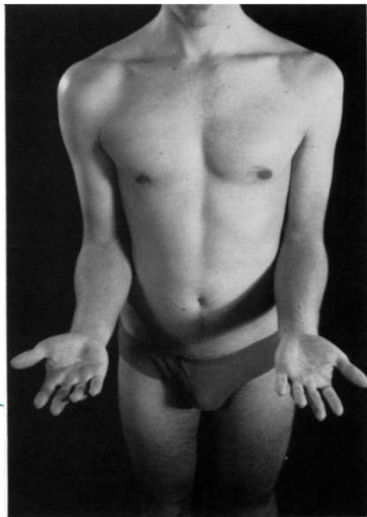
- « Montrez moi le dos de vos mains » (coude à 90°) !

- Déformation ou tuméfaction des poignets ou des doigts

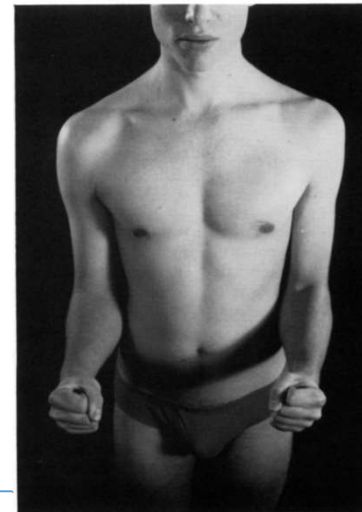
Examen clinique

De face : mouvement MS suite

- « Montrez-moi vos paumes »
 - Pro-supination (radio-ulnaire)
 - Coloration et
 - Trophicité palmaire



- Faite le poing !
 - Mobilité des doigts



Examen clinique

De face : mouvement MS suite

- Toucher le pouce avec chaque doigt !
 - Précision
 - Dextérité
- Etreinte des MCP
 - Synovite ?



Examen clinique

membres inférieurs inspection

Debout

- Varus / valgus des genoux ?
- Déformation des pieds et des orteils ?
- Voute plantaire

Couché

- Symétrie / trophicité des quadriceps
- Tuméfaction des genoux ?
- Déformation de l'avant-pieds et des orteils ?

Examen clinique

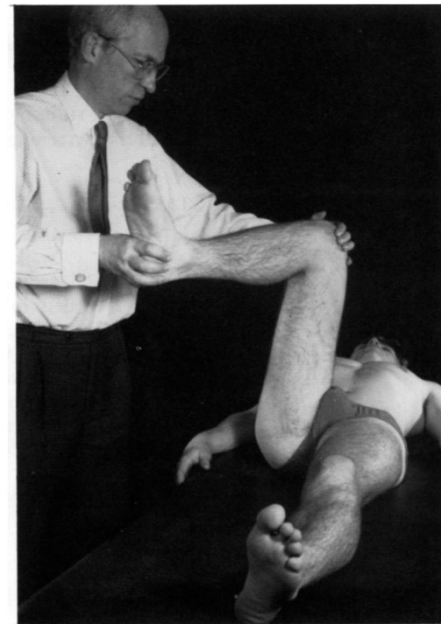
Membres inférieurs 2

- Amener le talon sur la fesse en fléchissant aussi la hanche
Droite puis gauche
Avec une main sur le genou

→ Vérifier la flexion complète des 2 articulations

→ Présence de crépitus du genou (signe d'arthrose)

- Rotations de hanche
Interne-externe



Examen clinique

Membres inférieurs 2

- Pression sur la rotule
 - Douleur ?
 - Epanchement ?

- Etreinte MTP
 - Synovite



- Présence de callosité sur la plante des pieds
 - Signe de trouble statique (rachidien ou membre inférieur)

Conclusion

- Une fois acquis cet examen prend moins de 3' et permet de détecter avec une bonne sensibilité un problème de l'appareil locomoteur.
- En cas d'anomalie un approfondissement de l'examen clinique de(s) articulation(s) concernée(s) devra alors être pratiqué.